

Dashboard de Risco de AVC — Triagem Populacional

Leitura consolidada de 50.000 perfis clínicos e comportamentais, construída para apoiar a priorização de acompanhamento médico. Todos os números refletem exclusivamente os dados presentes na base fornecida.

50.000

registros analisados

stroke_risk_prediction_dataset.csv

fonte dos dados

07/08/2026

data de geração

40 colunas

originais na base

PACIENTES ANALISADOS

50.000

100% da base fornecida

SCORE MÉDIO DE RISCO

54,8

Escala de 0 a 100

RISCO "ALTO"

24,2%

12.112 pacientes

PRECISAM DE CONSULTA MÉDICA

73,2%

36.579 pacientes sinalizados

PANORAMA GERAL

Quase 1 em cada 4 pacientes está em risco alto

Distribuição da base por categoria de risco e sinalização automática de consulta médica.

Distribuição por categoria de risco

Classificação derivada do Stroke_Risk_Score



Sinalização de consulta médica, por categoria

% de pacientes marcados como "necessita consulta" em cada grupo

CATEGORIA	% CONSULTA	PACIENTES
Alto	100,0%	12.112
Moderado	70,2%	34.375
Baixo	9,9%	3.513

Sinalização diretamente calibrada à categoria de risco: todo paciente de risco "Alto" é encaminhado.

O QUE MAIS PESA NO SCORE

Idade e pressão arterial lideram os fatores clínicos

Correlação de cada indicador clínico com o score de risco. Barras à direita aumentam o risco; à esquerda, reduzem.

Correlação dos indicadores clínicos com o score de risco

Correlações $|r| < 0,10$ foram omitidas por não serem relevantes



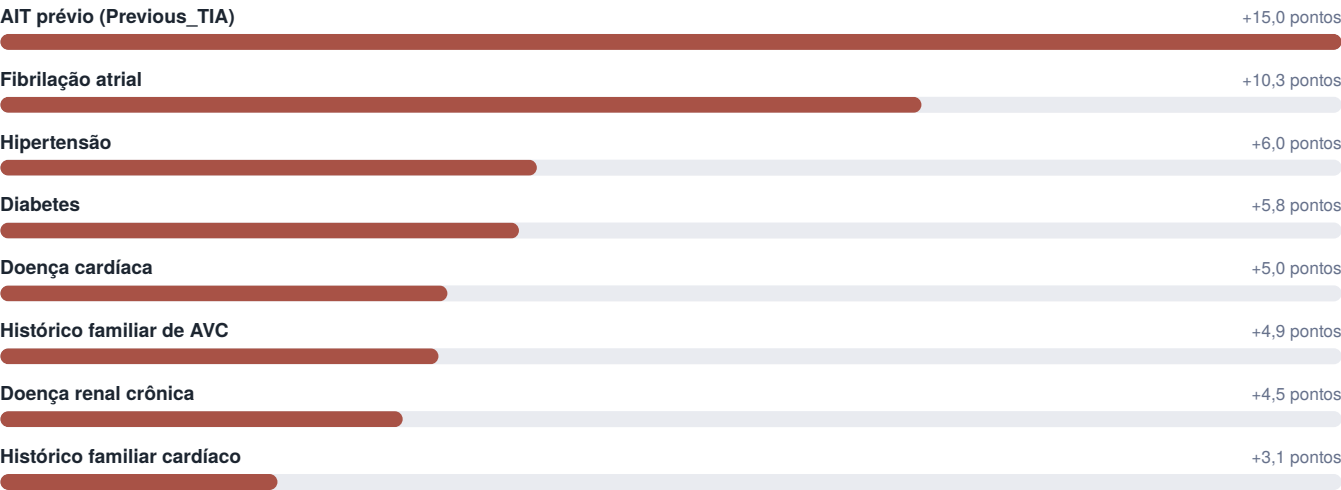
HISTÓRICO CLÍNICO

AIT prévio e fibrilação atrial têm o maior peso individual

Diferença no score médio entre pacientes com e sem cada condição pré-existente ou histórico familiar.

Impacto de comorbidades e histórico no score médio

Pontos adicionais no score médio (0–100) para quem tem a condição, vs. quem não tem



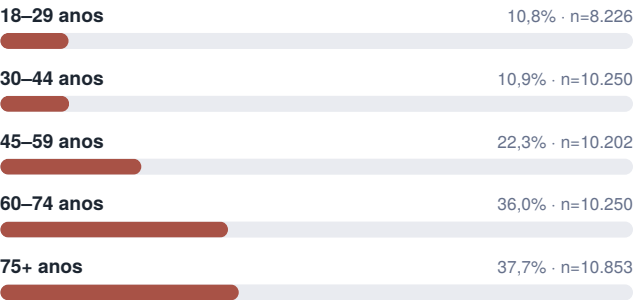
PERFIL ETÁRIO

O risco alto mais que triplica após os 45 anos

Proporção de pacientes classificados como risco "Alto" dentro de cada faixa etária.

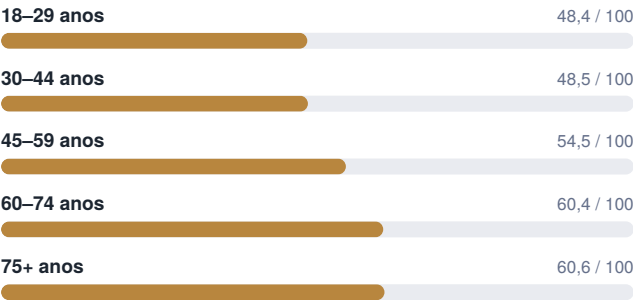
% de risco "Alto" por faixa etária

Idade ausente em 0,4% da base (219 registros)



Score médio de risco por faixa etária

Mesma faixa etária, escala contínua (0–100)



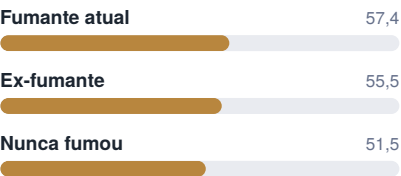
COMPORTAMENTO E ESTILO DE VIDA

Cada hábito de risco isolado pesa pouco — mas o efeito se acumula

Score médio de risco por categoria comportamental. Diferenças de 3 a 5 pontos entre extremos.

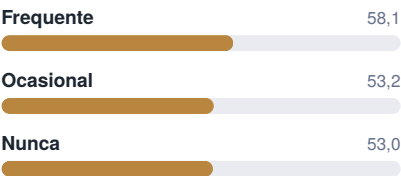
Tabagismo

Score médio de risco (0–100)



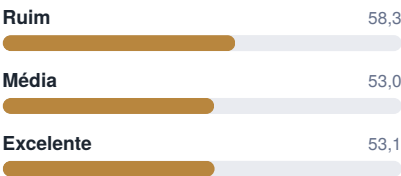
Consumo de álcool

Score médio de risco (0–100)



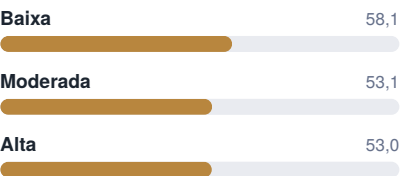
Adesão à medicação

Score médio de risco (0–100)



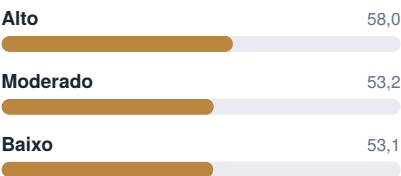
Atividade física

Score médio de risco (0–100)



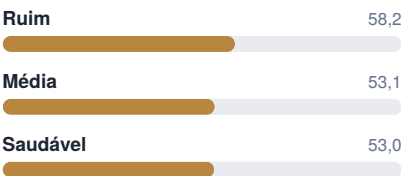
Nível de estresse

Score médio de risco (0–100)



Qualidade da dieta

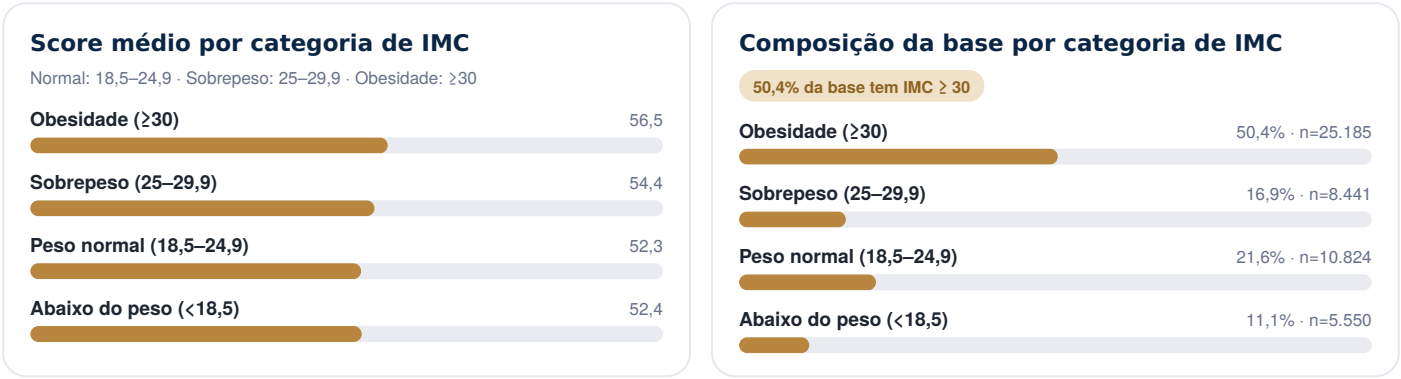
Score médio de risco (0–100)



COMPOSIÇÃO CORPORAL

Metade da base está classificada com obesidade

Distribuição do score médio por categoria de IMC.



TRANSPARÊNCIA ANALÍTICA

Qualidade e completude dos dados

Percentual de ausência por grupo de colunas e dimensões avaliadas, mas descartadas.

COLUNA(S)	% AUSENTE	TRATAMENTO APLICADO
Height_cm / Weight_kg	3,0%	Mantidas; exclusão pontual nos cálculos dependentes.
Medication_Adherence, LDL, Triglycerides, Exercise, Walking, Sleep	2,1%	Mantidas; mesmo tratamento.
HbA1c, Total_Cholesterol, HDL	2,0%	Mantidas; mesmo tratamento.
Blood_Glucose	1,9%	Mantida; mesmo tratamento.
Age	0,4%	Mantida; 219 registros excluídos apenas dos cortes por faixa etária.
Country e Gender	0%	Sem ausência, mas excluídas como dimensão : variação de score entre grupos <1,5 ponto — sem poder discriminante.
Distribuição geográfica	—	25 países com contagem quase idêntica (~2.000 cada) — padrão típico de base sintética/ simulada.

Principais insights

Leituras objetivas, baseadas exclusivamente nos dados analisados.

1 **Idade** (r=0,36) e **pressão sistólica** (r=0,31) são os fatores com maior correlação ao score — mais que qualquer hábito isolado.

2 **AIT prévio** (+15,0) e **fibrilação atrial** (+10,3) têm o maior impacto individual, acima de hipertensão (+6,0) e diabetes (+5,8).

3 O risco "**Alto**" passa de **10,8%** (18–29 anos) para **37,7%** (75+) — mais que triplica com o envelhecimento.

4 Hábitos de risco elevam o score entre **2,6 e 5,2 pontos** cada — efeito individual moderado, mas cumulativo.

5 **50,4%** da base tem obesidade (IMC ≥ 30) — maioria da população, não uma minoria de risco.

6 Consulta médica calibrada ao risco: **100%** dos pacientes de risco alto são encaminhados, contra **9,9%** dos de risco baixo.

7 **País e gênero** não mostram variação relevante (<1,5 ponto) — não usados como dimensões de corte.